

NOUVEAU-NE NORMAL

- * Coloration rose
- * Poids = 2500-4000g
- * Taille = 46-54cm
- * PC = 33-37 cm
- * FR = 40-60 cycles/min
- * FC = 100-160 battements/min
- APGAR = 8-10 en 5min
- * Strie plantaire > 2/3 antérieur
- * Nodule mammaire > 4mm
- * Lobule de l'oreille bien ourlée, testicule présent dans les bourses striées pour les garçons,
- * Les grandes lèvres recouvrent les petites chez les filles.

La crise génitale du nouveau-né se manifeste par le gonflement des seins, l'écoulement de liquide blanchâtre dans le sexe de la fille. **Elle est due à la prolactine.**
Administer le fer à J8 de vie.

NOUVEAU-NE PREMATURE

C'est un nouveau-né dont l'âge gestationnel est **inférieur à 37 SA.**

On a 4 groupes de prématurés :

- Petit prématuré (35-37(SA
- Grand prématuré (28-33(SA
- Moyen prématuré (33-35(SA
- Extrême prématuré (22-28 (SA

- * Causes médicales ou provoquées
- * Causes spontanées d'origine maternelle ou fœtale
- * **La principale** complication métabolique du nouveau-né prématuré est **l'hypoglycémie.**
- * Le nouveau-né prémature rattrape son **retard pondéral** entre **3 et 6mois.**
- * Administer le fer à J8 de vie.

NOUVEAU-NE HYPOTROPHE

C'est un nouveau-né à terme mais de faible poids de naissance (inférieur à 2500g).

On distingue deux (02) groupes :

- **Nouveau-né hypotrophe harmonieux** : il n'a pas les mensurations dans la limite de la

Normale (poids, taille et PC anormaux).

- **Nouveau-né hypotrophe dysharmonieux** : il a la taille et le PC normaux mais un poids anormal.

- Administer le Fer à J8 de vie

REANIMATION DU NOUVEAU-NE EN SALLE DE NAISSANCE

C'est donner vie, ressusciter un enfant de 0 à 28 jours en détresse vitale

On ne doit pas utiliser l'APGAR pour décider de la réanimation mais la minute d'or.

Entre 0 et 60 min de vie : mise au sein précoce, prendre 4 fois la température du bébé soit chaque 15min.

Entre 60 et 90 min de vie (soins essentiels) : Vit K1 en IM, collyre antiseptique dans les yeux, soins du cordon ombilical avec la Chlorhexidine,



prendre le poids du bébé, examiner le bébé, prendre encore la température du bébé.

DEROULEMENT DE LA GROSSESSE

Les étapes du développement du fœtus :

***le stade d'œuf (0-8^{ème} J de grossesse)**

***le stade d'embryon ou embryogénèse (8-90^{ème} J de grossesse)** : Cette période correspond à la mise en place et à la différenciation des organes du futur bébé. Ces organes sont formés à partir de **trois (03) feuillets** :

-L'ectoblaste : forme le tissu nerveux et la peau

le cœur, les vaisseaux sanguins, les muscles viscéraux et squelettiques, le tissu conjonctifs, les reins, les gonades et la plupart des organes

-L'endoblaste : forme les glandes, l'épithélium respiratoire, la muqueuse intestinale et sert de plaque nourricière pour les deux autres feuillets.

-Le mésoblaste : forme

internes.

***Le stade de fœtus (90^{ème} J de grossesse à la naissance)**

DETRESSE RESPIRATOIRE DU NOUVEAU-NE

*Connaitre le score de SILVERMAN et son interprétation

*Examen à réaliser :

Imagerie : radiographie du thorax

Biologie : Gazométrie, hémogramme, hémoculture, CRP

***Les causes de la détresse respiratoire du NN :**

-La maladie des membranes hyalines : due à un **déficit de sécrétion de surfactant** : prématuré

-Le retard de résorption du liquide alvéolaire : césarienne avant travail

-L'inhalation du liquide amniotique : accouchement difficile ou dystocique

-Infectieux : quand l'enfant naît dans un contexte infectieux

NB : le débit d'oxygène d'un nouveau-né souffrant de détresse respiratoire est de **0,5-1L/min**.

INFECTION BACTERIENNE DU NOUVEAU-NE

On distingue deux (02) types :

-Précoce ou materno-fœtale : < ou = à 7J de vie

-Tardive ou post-natale : > 7J de vie

***les germes responsables** :

-L'infection précoce ou materno-fœtale est causée par le **Streptocoque B**



-L'infection tardive ou post-natales est causée par la **Staphylocoque dorée**

***Pathogénie :**

- L'infection précoce ou materno-fœtale est contractée par **voie basse**, voie hématogène
- L'infection tardive ou post-natale est contractée par les mains sales, les gestes septiques, les soins septiques du cordon ombilical

*L'examen de certitude repose sur **l'hémoculture**.

***Le traitement**

- L'infection précoce ou materno-fœtale : **Amoxicilline ou Ampicilline + Aminoside** (Gentamycine ou Netilmicine)
- L'infection tardive ou post-natale : **Ceftriaxone ou Cefotaxine + Aminoside** (Gentamycine ou Netilmicine).

MALADIE HEMPORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE

***Définition**

Saignement du nouveau-né provoqué par un **déficit en Vitamine K1** ou en **facteurs vitamino K1 dépendants** (II, VII, IX, X).

***Fréquence**

Elle représente 1-2 cas sur 100 naissances et **le pic se situe entre J2 et J3 de vie** rare après J10.

***Facteurs favorisants :**

- La race noire
- Grossesse difficile
- Prématurité...

***Manifestation :**

-Méléna

-Saignement

***Examen**

L'examen de certitude repose sur le **Temps de Quick** encore appelé **TP/TCK, Taux de prothrombine, Temps de céphaline kaolin, Temps de céphaline activé (TCA)**.

***Prévention :**

- **Poids > ou = à 1500g : Vit K1 1mg en IM**
- **Poids <1500g : Vit K1 0,5mg en IM**

***Curatif :** quel que soit le poids de l'enfant, on fait **10mg de Vit K1 en IVD**

ALLAITEMENT MATERNEL

***L'allaitement maternel** est l'alimentation du bébé par le sein.

***L'allaitement exclusif** est l'alimentation du bébé par le lait maternel de 0 à 6 mois de vie **sans ajouter de l'eau ni de jus à l'exception de médicaments**.

*Le taux d'allaitement exclusif en Côte d'Ivoire est de **23%**.*

NB : pour une bonne montée laiteuse, l'OMS préconise **la mise au sein précoce** qui est le fait de donner le sein au bébé dans la première heure de vie (**0-60 min de vie**).

***L'allaitement prépondérant** est l'alimentation du bébé par le lait maternel en plus du jus ou de l'eau.

***L'allaitement mixte** est l'alimentation du bébé par le sein + le biberon.



*La mise au sein précoce représente **36%** en Côte d'Ivoire.*

***Le sevrage**

- *Début du sevrage à 6mois ;*

- *Sevrage définitif à 2ans.*

***Physiologie de la lactation**

- **La prolactine** : c'est l'hormone de **production du lait maternel** en agissant sur **les cellules épithéliales au niveau des acini**. C'est aussi le reflexe prolactinique ou le réflexe de sécrétion du lait maternel.

La prolactine est produite au niveau l'hypophyse antérieure ou l'anté-hypophyse.
Cette production est stimulée **par la succion du mamelon.**

- **L'ocytocine** : c'est l'hormone **d'éjection** du lait maternel en **agissant sur les cellules myoépithéliales**. C'est aussi le reflexe ocytocique ou le réflexe d'éjection du lait maternel.

L'ocytocine est produite au niveau de l'hypophyse postérieure ou la post-hypophyse. Cette production est stimulée **par la succion du mamelon, la vue du bébé par sa mère et le son de la voix du bébé ou ses pleurs.**

La production de l'ocytocine est stoppée par l'anxiété, la douleur, le manque de confiance c'est pourquoi la maman doit être dans un environnement paisible.

***Composition du lait maternel**

- **Le colostrum** : c'est le premier lait produit entre J0 et J7. Il est riche en anticorps, facteurs de croissances, cytokines, oligosaccharides...

et J21. Il est riche en lipide, lactose. Sa couleur est jaune orangé.

- **Le lait de transition** : produit entre J7

- **Le lait mature** : produit à partir de la **3^{ème} semaine (> J21)**. Il est riche en lipide, protéine, glucide, eau.

***Comparé au lait de vache, le lait maternel est stérile, contient des probiotiques et est supérieur au lait de vache.**

***Un enfant nourri au sein normal prend 25 à 30g de poids par jour et ses selles sont de couleur jaune or aspect œuf brouillé.**

***Nombre de tétée = 8 à 9 fois par jour.**

***La mère allaitante a droit à 3 repas équilibré par jour et doit boire 1,5 à 2L d'eau par jour en dehors des repas.**

***Les critères d'un bon positionnement au sein (voir la bible)**

***Les critères d'une bonne prise de sein (voir la bible)**

***les critères d'une tétée efficace (voir la bible).**

CROISSANCE DE L'ENFANT

La croissance de l'enfant a deux (02) volets :

- **La croissance somatique ou quantitative** : c'est l'augmentation en taille, poids, surface corporelle, tous les organes et tissus.



- **La croissance qualitative ou la mutation** : c'est la multiplication et le perfectionnement des structures et des fonctions au cours de l'évolution vers l'état adulte.

***Surveillance de la croissance somatique :**

- **Poids** : pèse bébé pour l'enfant de moins de 2ans et pèse personne pour l'enfant de plus de 2ans.

pour l'enfant de plus de 2ans.

- **PC et PB** : mètre ruban quel que soit l'âge.

- **Taille** : toise horizontale pour l'enfant de moins de 2ans et toise verticale

***Surveillance de la croissance qualitative :**

* Fontanelles (antérieure et postérieure)

* Eruption dentaire

* Points d'ossification

***Les 2 étapes de la croissance :**

- **A 3mois** : l'enfant double son poids de naissance (**PNx2**)

de naissance (**PNx4**) et prend 2kg chaque année à partir de 3ans

- **A 9mois** : l'enfant double sa surface corporelle de naissance (**SCNx2**)

- **A 3ans** : l'enfant triple sa surface corporelle de naissance (**SCNx3**)

- **A 12mois** : l'enfant triple son poids de naissance (**PNx3**)

- **A 4ans** : l'enfant double sa taille de naissance (**PNx2**)

- **A 2ans** : l'enfant qua triple son poids

*La fontanelle postérieure se ferme **2 à 3mois**

*La fontanelle antérieure se ferme à **18 mois**

*On parle de **retard d'éruption dentaire** si l'enfant n'a aucune dent après **15 mois**

***Les facteurs de croissance**

-L'hérédité

-Les hormones

-L'environnement

DIARRHÉE AIGUE ET DESYDRATATION

La diarrhée est l'émission de plus de 3 selles molles ou liquide par 24h.

- **La diarrhée aigue** est une diarrhée qui dure depuis **moins de 14J.**

persistante est une diarrhée dont la durée est comprise **entre 14 et 21J.**

- **La diarrhée chronique** est une diarrhée qui évolue depuis **plus de 21J.**

- **La diarrhée**

On distingue deux (02) groupes de causes :

- **La diarrhée aigue infectieuse** due le plus souvent par des virus dont le plus fréquent est la rotavirus ; des bactéries dont le plus connu shiguelle.

Donc : **la diarrhée aigue est due au rotavirus et la diarrhée bactérienne au shiguelle.**

- **La diarrhée aigue non infectieuse** est



due au stress, l'erreur de nutrition ou d'antibiotiques...
diététique, la prise inappropriée

* On n'impose pas la diète à un enfant qui fait la diarrhée.

* Problèmes

- La **déshydratation+++**
- L'hygiène
- La dénutrition
- C'est pourquoi il faut évaluer l'état de l'enfant afin de le réhydrater.

*Le soluté idéal de réhydratation par voie parentérale est le ringer lactate (RL). A défaut, on utilise le sérum glucose isotonique 5% (SGI5%)

* La composition du SRO selon l'OMS :

- Composition en grammes/Litre = 20,5g/L selon le poids légal.
- Composition en mmol/Litre = 245 selon l'osmolarité totale

* CALCUL SELON LES PLANS DE REHYDRATATION :

PLAN A (pas de signes de déshydratation) :

- ✓ Larmes présentes
- ✓ Bouche humide
- ✓ Pas de soif et
- ✓ Le pli cutané s'efface rapidement

(-) 24 mois on donne 500ml/j soit 50-100ml de SRO après chaque selle molle ou liquide

2 à 10ans on donne 1000ml/j soit 100-200ml de SRO après chaque selles molles ou liquides

10ans (+) on donne 2000ml/j de SRO autant qu'il en voudra

PLAN B (signes évidents de déshydratation) :

- ✓ Agité
- ✓ Irritable
- ✓ Yeux enfoncés
- ✓ Larmes absentes
- ✓ Bouche sèche
- ✓ Boit avec avidité
- ✓ Le pli cutané s'efface lentement

Q= 75ml/kg en 4h

Au bout de ces 4h on évalue l'état de l'enfant, si disparition des signes de déshydratation on retourne au Plan A, si persistance des signes de déshydratation, on reconduit le **Plan B** et si aggravations des signes de déshydratation on passe au **Plan C**.

PLAN C (signes sévères de déshydratation) :

- ✓ Léthargique ou inconscient,
- ✓ Yeux très enfoncés,



✓ Larmes absentes, bouche très sèche

✓ Incapable de boire

✓ Le pli cutané s'efface très lentement

(-) 1an on fait 30ml/kg en 1h puis 70ml/kg en 5h

+1an on fait 30ml/kg en 30min puis 70ml/kg en 2h30min

* Il faut poursuivre l'alimentation de l'enfant pour prévenir la malnutrition car le tube digestif conserve 50 à 70% de ses capacités d'absorption et donne à l'enfant du Zinc comprimé dosé à 20mg par voie orale pendant 10J.

Posologie du Zinc 20mg comprimé :

- De 0 à 6 mois on donne un demi cp / j
soit 10mg

- Entre 6 mois et 5 ans on donne 1 cp / j
soit 20mg.

FIEVRE DE L'ENFANT

La fièvre est l'élévation de la température corporelle prise par voie rectale en dehors des repas et exercice physique au-dessus de 37°C le matin et 38°C le soir.

* Complications de la fièvre : la convulsion, la déshydratation, l'hyperthermie majeure.

* Classification de la fièvre :

Selon la durée d'évolution

- la fièvre aiguë (<8J)

- la fièvre prolongée(8-30jours)

- la fièvre chronique (>30joiurs)

Selon le degré thermique

- la fièvre modérée (37°C-38°C)

- la fièvre élevée (38°C-40°C)

- l'hyperthermie (>40°C)

La température corporelle : c'est l'équilibre entre la production et la perte de chaleur (36°C et 37,5°C), Le déséquilibre ou la perturbation de la thermorégulation au niveau de l'hypothalamus en dessous ou au-dessus de la normale est donc signe d'une hypothermie ou d'une hyperthermie.

Le thermomètre recommandé pour prendre la température est le thermomètre électronique. On n'utilise pas le thermomètre à mercure car il est un risque cancérigène.

* Appréciation de la tolérance

Bonne

Mauvais

Faciès . Vultueux, yeux brillants

péribuccale

. Pale, cyanose

Cri . Vigoureux

. Plaintif

Téguments . Chauds, Erythrosique

. Marbrures, Extrémité

froide



TRC	. Immédiat < 3secondes	. > 3 secondes
Conscience	. Normale	. Altérée (sommolence, coma)

NB : les éléments notés au **vert** signifient que l'enfant **tolère sa fièvre** et ceux en **rouge** signifient que l'enfant **ne tolère pas sa fièvre**.

***Traitement de la fièvre**

Pour traiter la fièvre de l'enfant, il existe des moyens physiques prouvés et des moyens médicamenteux.

***Les moyens physiques prouvés (rôles propres de l'IDE/SFDE) :**

- Déshabiller l'enfant
- Eviter de couvrir l'enfant
- Aérer la pièce
- Faire boire à l'enfant le plus souvent possible

*** Les moyens médicamenteux (rôles délégués de l'IDE/SFDE) :**

- | | | |
|--|--|---|
| - Paracétamol :
60mg/kg en 3-4 prises
par voie orale, IVDL, IR | - Ibuprofène : 7-
10mg/kg en 3 prises
par voie orale | - Aspirine : 50-60mg/kg
en 3 prises par voie
orale, IVD |
|--|--|---|

Le paracétamol est le médicament le plus recommandé, une mauvaise utilisation de l'ibuprofène et l'Aspirine aggraverait la maladie de l'enfant s'il souffre d'une dermatose telle que la varicelle.

PALUDISME DE L'ENFANT

C'est ***une maladie parasitaire*** qui touche les globules rouges et *due à un parasite du genre*

Plasmodium dont le plus connu **le Plasmodium falciparum**.

Elle est transmise par l'anophèle femelle hématophage et touche surtout les enfants de moins de 5ans dans les régions tropicales chaudes et humides.

*** Pathogénie :**

Elle résulte de deux (02) théories :

- *Théorie mécanique : les globules rouges parasités possèdent à leur surface des renflements appelés **KNOB**.*
- *Théorie immunologique : la présence du parasite dans l'organisme occasionne la production de toxines (cytokine) à l'origine de l'altération de l'état général.*

*** Les formes de paludisme**

- **Le paludisme simple**



Signes :

- ✓ Fièvre
- ✓ Frissons
- ✓ Diarrhée
- ✓ Courbatures
- ✓ Céphalée
- ✓ Vomissements...

- **Le paludisme grave** : est définie selon les manifestations cliniques et biologiques

Manifestations cliniques :

- ✓ Modification du comportement,
- ✓ Confusion
- ✓ Somnolence
- ✓ Convulsions à répétition,
- ✓ Coma
- ✓ Prostration
- ✓ Ictère
- ✓ Œdème pulmonaire ou difficulté respiratoire
- ✓ Respiration profonde ou détresse respiratoire
- ✓ État de choc ou collapsus cardiovasculaire.

Manifestations biologiques :

- ✓ Hypoglycémie,
- ✓ Hémoglobine <7g/dl (anémie sévère)
- ✓ Acidose métabolique
- ✓ hyperlactatémie
- ✓ Hémoglobinurie (sang dans les urines)
- ✓ hyperparasitémie
- ✓ Insuffisance rénale.

NB : les formes de gravité les plus fréquentes sont neurologique et anémique.

* **Diagnostic biologique** : **Goutte Epaisse (GE) et le Frottis sanguin.**

A défaut de ces examens, le diagnostic peut se faire par le TDR au lit du malade ou le QBC.

* **Traitement du paludisme simple (CAT) :**

- Artéméther + Luméfantrine comprimé - Artésunate + Amodiaquine comprimé

* **Traitement paludisme grave** (se fait à l'hôpital de référence) :

- Artésunate injectable
- Sel de Quinine en perfusion
- Artéméther injectable

ANEMIE DE L'ENFANT

L'anémie est la diminution du taux d'hémoglobine en dessous de 11g/dl.

On en distingue deux (02) types :

- L'anémie aigue : < ou = à 14J
- L'anémie chronique : > 14J

- **Anémie modérée** : Taux Hb entre 11-7g/dl

- **Anémie sévère** : Taux Hb < 7g/dl

* **Classification** :

- **Pas d'anémie** : Taux Hb > ou = à 11g/dl

* **Principaux types d'anémie** :



- L'anémie microcytaire hypochrome :

c'est l'anémie par carence en fer

- L'anémie normocytaire

normochrome : c'est l'anémie due au paludisme

- L'anémie macrocytaire

normochrome : c'est l'anémie par carence en acide folique ou Vitamine B9

* Calcul du débit de la transfusion :

Quantité(ml) / 4 x H(heure) = gouttes par minute.

MALNUTRITION DE L'ENFANT

La malnutrition résulte d'une mauvaise façon de nourrir l'enfant soit par excès ou par défaut

Elle est rare avant 6mois, survient entre 6 mois et 36 mois et très rare après 36 mois.

* Malnutrition type Kwashiorkor

- ✓ Pic : entre 18 et 36mois récente
- ✓ Début brutal
- ✓ Sevrage brutal ou maladie

Elle est entraînée par un déficit en nutriment de *type 1* (macronutriments) : glucides, lipides, protides. Ces aliments produisent de l'énergie.

Un enfant souffrant du Kwashiorkor présente les signes suivants :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ Anorexie ou refus de manger | ✓ Des Œdèmes |
| ✓ Il est grognon | ✓ Des ulcérations et desquamations. |
| ✓ Bouffissure du visage | |

* Malnutrition type Marasme

Pic : 12mois

Début progressif

Mauvaise conduite de la diversification alimentaire

Le marasme est entraîné par un déficit en nutriment de *type 2* (micronutriments) : vitamines, sels minéraux...

L'enfant présente les signes suivants :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ✓ Retard pondéral | ✓ Alopécie |
| ✓ Fonte grasseuse et musculaire | ✓ Amaigri |
| ✓ Faciès de vieillards | ✓ Un appétit conservé |

* Le Z-score est utilisé pour diagnostiquer la malnutrition.

* Problèmes :

- Hypoglycémie+++
- Déshydratation (50-80% de décès) +++



*** Lieu de réhabilitation nutritionnelle :**

- **Unité de nutrition thérapeutique (UNT)** : Malnutrition aigüe sévère avec complications
- **Unité de nutrition thérapeutique ambulatoire (UNTA)** : malnutrition
- **Centre nutritionnel de supplémentation (CNS)** : Malnutrition aigüe modérée

* La réhabilitation nutritionnelle se fait avec les mélanges de l'Institut National de Santé

Publique d'Adjamé (INSP) et les laits thérapeutiques de l'OMS :

- Compositions des mélanges de l'INSP d'Adjamé :

- **Mélange I** : 6 volumes de lait entier en poudre + 2 volumes sucre en poudre + 1 volume d'huile (621).
- **Mélange II** : 5 volumes de lait entier

Ces mélanges sont faits avec la petite boîte de tomate (100f) vidée.

Le mélange II nécessite une cuisson en raison de la farine.

- Les laits thérapeutiques F75 et F100 :

- **Le lait F75** est sous forme de poudre en sachet de 410g. Pour le préparer, on dilue le contenu dans 2 Litres d'eau et il est utilisé pendant la phase d'initiation.
- **Le lait F100** est un lait écrémé en sachet de 456g. Pour le préparer, on dilue le contenu dans 2,7 Litres d'eau et il est utilisé pendant la phase de récupération ou de réhabilitation nutritionnelle. Il est riche en lipides et protides.

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES (IRA)

Ce sont des infections qui siègent au niveau du tractus respiratoire supérieur et inférieur.

Elles sont la 2^{ème} cause de consultation et de décès après le paludisme Côte d'Ivoire.

Elles touchent surtout les enfants de moins de 5ans.

Avant 3ans elles sont essentiellement virales c'est pourquoi on ne prescrit pas d'antibiotiques et après 3ans, on peut prescrire antibiotiques car elles sont essentiellement bactériennes.

La prévention repose sur l'hygiène individuelle et collective mais surtout la

vaccination. *Facteurs favorisants : voir cours

* Les différents types d'IRA :



- Haut appareil respiratoire

- ✓ Rhinopharyngite
- ✓ Angine

- ✓ Otite moyenne aigue

- Bas appareil respiratoire

- ✓ Bronchite aigue
- ✓ Bronchiolite

- ✓ Pneumonie

* Les germes responsables des IRA

- Les virus

- ✓ Coronavirus+++
- ✓ Virus respiratoire syncitial+++

- ✓ Virus para influenzae
- ✓ Rhinovirus

- Les bactéries

- ✓ Pneumocoque
- ✓ Haemophilus influenzae

- ✓ Mycoplasma pneumoniae

* Les principales IRA hautes :

- Rhinopharyngite

Age : 6mois-3ans

Germe responsable : Virus respiratoire syncitial

Signes : rhume, fièvre, obstruction nasale, mal de gorge, ganglions au cou

NB : On ne prescrit pas d'antibiotiques

Complications : otite moyenne aigue, Bronchite aigue

- Angine

Age : 4-10ans

gorge, enduit blanchâtre dans la gorge

Germe responsable : Streptocoque A

On prescrit antibiotiques

Signes : fièvre, vomissement, mal de

Complication : RAA

- Otite moyenne aigue

Age : 8mois-3ans

tympan rouge bombé ou perforé

Germe responsable : Pneumocoque

Complication : mastoïdite

Signes : fièvre, pleurs incessant, troubles digestifs, otalgie, otorrhée,

On prescrit antibiotiques

* Les principales IRA basses :

- Bronchite aigue

Age : nourrisson et grand enfant

syncitial

Germe responsable : Virus respiratoire

Signes : toux quinteuse ou grasse



On ne prescrit pas d'antibiotiques

Bronchiolite

Age : 1 mois-2 ans

Germe responsable : **Virus respiratoire syncytial**

Signes : toux, respiration sifflante, fièvre, rhume

On ne prescrit pas d'antibiotiques

Pneumonie

Age : **après 5 ans**

Germe responsable : **Pneumocoque**

Facteurs favorisants : **Drépanocytose**

condensation

Bilan : Rx thorax, CRP, Hémogramme

On prescrit antibiotique

Signes : toux, douleur thoracique, dyspnée, fièvre, perlèche labiale, troubles digestifs, ictère, syndrome de

***Implications pour les soins infirmiers :**

Atteinte au niveau de la **Zone de conduction** se manifeste par un encombrement et une *obstruction des voies respiratoires*

Rôle de l'IDE/SFDE : Dégager les voies respiratoires

Il s'agit des affections suivantes : Rhinopharyngite, Angine, Otite moyenne aigue, Sinusite,

Laryngite = *Dégagement inefficace des voies respiratoires.*

Atteinte au niveau de la **Zone d'échange** se manifeste par une perturbation des échanges gazeux.

Il s'agit des affections suivantes : Pneumonie, Asthme, Bronchite aigue, Bronchiolite, Rhume = *Perturbation des échanges gazeux.*

CONVULSIONS DE L'ENFANT

*** Crise convulsive :**
contraction involontaire du muscle squelettique par l'hyperexcitabilité d'une population de neurones cérébraux

*** Situation clinique :**

- Phase tonique
- Phase clonique

hyper synchrones.

*** Etat de mal convulsif :**
crise convulsive qui dure plus de 30min ou crises subintrantes sans reprise de la

conscience inter critique.

*** Epilepsie :** récurrence ou répétition de crises convulsives.

* Pour arrêter les convulsions de l'enfant, il faut lui injecter du **Diazépam (Valium)** en raison de **0,5mg/kg** en Intra rectale.

